

Przepisywanie obrazów (*imagery rescripting*)

Wizualizacja sceny upokorzenia z dzieciństwa, **dorosły „ja”** **wchodzi i broni dziecka**. Lee & James 2012: $d = 0,81$ dla redukcji wstydu. Szczególnie skuteczne w AvPD — wstyd zakodowany w obrazach.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna

ŹRÓDŁO: Arntz & Weertman (1999); Lee & James (2012); Arntz, Sloots & Hagenaars (2015)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz, dlaczego sama *praca poznawcza* ze wstydem odbija się od ściany (sekcja 01). **2** · Poznasz mechanizm **rekonsolidacji pamięci emocjonalnej** (sekcja 02). **3** · Poznasz *pięcioetapową strukturę* sesji przepisywania obrazów (ang. *imagery rescripting*) (sekcja 03). **4** · Zobaczysz **warunki bezpieczeństwa** — kiedy **NIE** rozpoczynać (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Przepisywanie obrazów (ang. *imagery rescripting*, Arntz & Weertman 1999) — wizualizacja wczesnej sceny odrzucenia/upokorzenia, w której Dorosły „ja” wchodzi do sceny i broni Dziecka — jest jedną z **najsilniejszych technik** w AvPD, gdy schemat defektywności pochodzi z konkretnych pamiętnych wydarzeń. Lee & James (2012, metaanaliza): redukcja wstydu i negatywnych emocji z $d = 0,81$. W AvPD **szczególnie skuteczne** — bo wstyd jest **zakodowany w obrazach**, nie w słowach (więc *obrazy* najlepiej go zmieniają). Klasyczna praca poznawcza („to nie była twoja wina, miałeś 7 lat”) generuje *intelektualną zgodę*, ale **emocjonalny ładunek** wspomnienia pozostaje. Pacjent „wie”, że nie zawinił — i wciąż czuje wstyd, gdy o tym myśli. Bo schemat został zakodowany *emocjonalnie*, nie poznawczo. *Imagery rescripting* przemawia w języku **pamięci emocjonalnej**: terapeuta prowadzi Dorosłego „ja” do wejścia, ochrony Dziecka, powiedzenia oprawcy/krytykowi tego, czego Dziecko nie mogło powiedzieć. Mózg przetwarza to jako *doświadczenie*, nie abstrakcję. Po sesji: emocjonalny ładunek wspomnienia mierzalnie spada (SUDS).

01 Dlaczego sama praca poznawcza nie wystarcza

KLASYCZNA PRACA POZNAWCZA

„To nie była twoja wina, miałeś 7 lat”. Pacjent: „*wiem, ale i tak czuję wstyd*”. Intelektualna zgoda. Emocjonalny ładunek **nie spada**.

PRZEPISYWANIE OBRAZÓW

Pacjent *wraca* do sceny, terapeuta prowadzi Dorosłego do wejścia, ochrony Dziecka. Pamięć epizodyczna. **Doświadczenie**, nie abstrakcja. Ładunek mierzalnie spada.

Mechanizm różnicy: wspomnienia traumatyczne są przechowywane w *pamięci emocjonalnej* (amygdala, hipokamp), oddzielonej od pamięci semantycznej. Praca słowna pracuje na pamięci semantycznej („wiem, że...”) — nie sięga emocjonalnej. *Imagery rescripting* **aktywuje wspomnienie** (rekonsolidacja) i modyfikuje je przed ponownym zakodowaniem.

02 🕒 Rekonsolidacja pamięci — mechanizm

AKTYWACJA
wizualizacja sceny
w wyobraźni

DESTABILIZACJA
śląd pamięci

plastyczny przez ~6 godzin **NOWE DOŚWIADCZENIE** Dorosły broni Dziecka w obrazie **REKONSOLIDACJA** ślad modyfikowany, SUDS spada

Mechanizm Nader 2000: wspomnienie *aktywowane* staje się *plastyczne* przez około 6 godzin. Nowe doświadczenie emocjonalne w tym oknie **modyfikuje** oryginalny ślad pamięciowy. Pacjent zapamiętuje scenę z nową emocją: ulgą, walidacją, bezpieczeństwem. Lane i wsp. (2015): to *nie* metafora — to udokumentowana neurobiologia. Efekt podobny do EMDR, choć inny mechanizm.

03 ✎ Pięć kroków sesji *imagery rescripting*

- 1 • Wybór sceny** — wczesne wspomnienie wstydu/upokorzenia. Ma być żywe, nie najgorsze — najgorsze wymaga większego aliansu.
- 2 • Wizualizacja jako dziecko** — pacjent zamyka oczy, *wraca do sceny w pierwszej osobie*. Co widzi, słyszy, czuje w ciele? *Co czuje to dziecko?*
- 3 • Wejście dorosłego/-ej** — pacjent jako *dorosły* wchodzi do sceny. Mówi do dziecka: „*nie jesteś wadliwy. To, co się dzieje, jest niesprawiedliwe*”. Mówi do oprawcy to, czego dziecko nie mogło.
- 4 • Dziecko słyszy** — terapeuta pyta: „*co czuje dziecko, słysząc to?*”. Płacz, ulga, niedowierzanie są normalne. **To moment rekonsolidacji.**
- 5 • Integracja** — wyjście ze sceny, oddech, refleksja. „Co się zmieniło?” „Co teraz wiesz, czego nie wiedziałeś/-aś wcześniej?”. Notatka w dzienniku.

04 💡 Warunki bezpieczeństwa — kiedy **NIE** rozpoczynać

KIEDY **NIE**

Pierwsze sesje terapii. Aktywna depresja albo myśli samobójcze. Świeży kryzys. Pacjent dysocjuje. Brak ustabilizowanego aliansu. Niestabilna sytuacja życiowa.

KIEDY **TAK**

Po 6-12 miesiącach budowania aliansu. Pacjent *uznał* emocjonalny ból. Stabilna sytuacja życiowa. Doświadczony terapeuta schematów lub TFP. Wsparcie psychiatryczne w razie potrzeby.

Klucz: *imagery rescripting* w AvPD to **przełom** — pacjent *czuje* korektę wstydu, nie tylko o niej myśli. Często płacze pierwszy raz w terapii. To *nie* dramatyzacja — to rekonsolidacja pamięci epizodycznej (Nader 2000; Lane 2015). Lee & James 2012: $d = 0,81$ dla redukcji wstydu. Warunek wstępny: **6-12 miesięcy budowania aliansu**. Bez tego — dropout, dysocjacja albo blokowanie obrazu. *Imagery rescripting* *nie* jest pierwszą interwencją w AvPD — jest **kluczową interwencją** w fazie pracy z rdzeniem schematu (1-3 lata terapii).